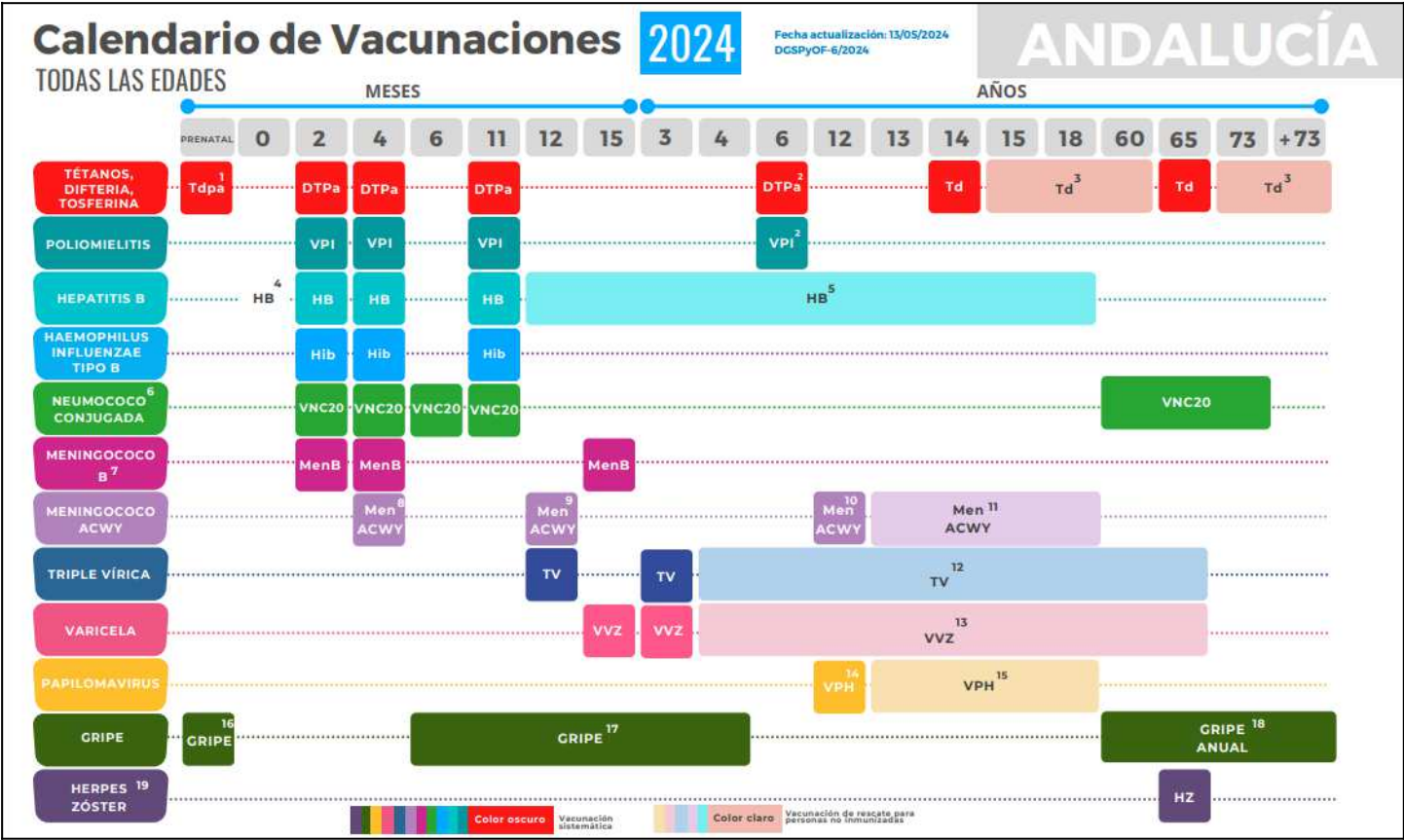


Capitulo : VACUNAS

Autores: Elena Jimenez Romano, Montserrat Gómez Olmedo, Carmen Díaz Molina

Calendario de Vacunaciones de Andalucía 2024. Todas las edades.



Leyenda:

DTPa: Vacuna frente a tétanos, difteria y tosferina acelular de alta carga o infantil.

Tdpa¹: Vacuna frente a tétanos, difteria y tosferina acelular de baja carga antigénica. 1 dosis de Tdpa (Boostrix®) en cada embarazo a partir de la semana 27 de gestación, pero preferentemente en las semanas 27 o 28.

DTPa²: **Vacuna DTPa-VPI a los 6 años (Tetraxim®):** 1 dosis de Tetraxim® a los nacidos a partir del 1 de enero de 2017, que recibieron un esquema 2+1 (2, 4 y 11 meses). Los nacidos antes de 2017 (recibieron un esquema 3+1: 2, 4, 6 y 18 meses) que no hayan recibido aún la dosis de Tdpa de los 6 años, recibirán una dosis de vacuna Tdpa sin polio (Boostrix®).

Td³: Vacuna frente a tétanos y difteria tipo adulto.**Vacuna Td (Diftavax®):** verificar el estado de vacunación previo antes de iniciar o completar una pauta de primovacunación con Td en personas adultas. El contacto con los servicios sanitarios, incluyendo los de prevención de riesgos laborales, se utilizará para revisar el estado de vacunación y, en caso necesario, se vacunará con Td hasta completar 5 dosis. Se administrará una dosis de Td en torno a los 65 años a las personas que recibieron 5 dosis durante la infancia y la adolescencia.

VPI²: Vacuna frente al virus de la poliomielitis inactivada. **Vacunación sistemática VPI a los 6 años:** a partir de enero de 2023, los menores que cumplan 6 años (menores nacidos a partir del 1 de enero de 2017), recibirán la vacuna DTPa-VPI (Tetraxim). Los nacidos antes de 2017 que no hayan recibido aún la dosis de Tdpa de los 6 años, recibirán una dosis de vacuna Tdpa (Boostrix).

HB⁴: Vacuna frente a hepatitis B. **Vacuna monocomponente frente a hepatitis B en el recién nacido:** en recién nacidos de madre con hepatitis B (AgHBs+) se administrará la primera dosis en las primeras 24 horas de vida (preferentemente primeras 12 h), junto con la administración de inmunoglobulina anti-HB. En caso de madre con AgHBs desconocido, si no podemos disponer de los resultados en las primeras 24 h de vida, el neonato también recibirá una dosis de vacuna de hepatitis B. En todos ellos siempre se continuará con el esquema estándar de vacuna hexavalente: 2, 4 y 11 meses. En estos menores, por tanto, se realiza una pauta con 4 dosis de hepatitis B: a los 0, 2, 4 y 11 meses de edad.

HB⁵: **Vacuna monocomponente frente a hepatitis B en adolescentes y jóvenes:** en personas no vacunadas con anterioridad, hasta los 18 años de edad, se administrarán 3 dosis, con pauta 0, 1 y 6 meses.

Hib: Vacuna frente a *Haemophilus influenzae* tipo b.

VNC⁶: **Vacuna frente a neumococo conjugada:** administración de forma sistemática de la vacuna neumocócica conjugada 20-valente (VNC20: Prevenar 20® o Apexxnar®) a los 2, 4, 6 y 11 meses. Administración sistemática de la vacuna neumocócica conjugada 20-valente (VNC20: Prevenar 20® o Apexxnar®) a todas aquellas personas nacidas entre el 1 enero 1951 y 31 diciembre 1963 que no hayan recibido VNC13 o VNC20 previamente.

MenB⁷: **Vacuna frente a meningococo B (Bexsero®):** sólo para nacidos a partir del 1 de octubre de 2021.

Men ACWY⁸: **Vacuna frente a meningococo ACWY a los 4 meses (Nimenrix®):** se administrará 1 dosis de Nimenrix® sólo a los nacidos a partir del 1 de octubre de 2023. También se les administrará a los lactantes nacidos antes de esta fecha y que no hayan recibido aún ni la vacuna del meningococo C ni la del meningococo ACWY.

Men ACWY⁹: **Vacuna frente a meningococo ACWY a los 12 meses (MenQuadfi®):** se administrará 1 dosis de MenQuadfi®.

Men ACWY¹⁰: **Vacuna frente a meningococo ACWY a los 12 años (MenQuadfi®):** se administrará una dosis de MenQuadfi® a los adolescentes de 12 años (nacidos en 2012) que no hayan recibido una dosis de meningococo ACWY (Nimenrix®, MenQuadfi® o Menveo®) después de los 10 años de edad.

Men ACWY¹¹: **Vacuna de rescate frente a meningococo ACWY de 13 a 18 años (MenQuadfi®):** se administrará 1 dosis de MenQuadfi® a aquellos de 13 a 18 años (nacidos entre 2005 y 2011) que no hayan recibido previamente ninguna dosis de cualquier vacuna frente a meningococo ACWY (Nimenrix®, MenQuadfi® o Menveo®).

TV¹²: Vacuna triple vírica frente a sarampión, rubeola y parotiditis. **Vacuna de rescate con triple vírica (TV) (M-R-V-VaxPro®):** se aprovechará el contacto con los servicios sanitarios, incluyendo los de prevención de riesgos laborales, para revisar el estado de vacunación. Se recomienda la vacunación en personas de hasta 65 años sin historia de vacunación ni constancia de antecedente de padecimiento del sarampión. En caso necesario, se administrarán 2 dosis de TV con un intervalo mínimo de 4 semanas entre dosis. En caso de haber recibido una dosis con anterioridad se administrará una dosis de TV. Esta vacunación está contraindicada en embarazadas y en personas inmunodeprimidas.

VVZ ¹³: Vacuna frente a virus varicela zóster. **Vacuna de rescate con (Varivax®):** en personas de hasta 65 años que no refieran antecedentes de haber pasado la varicela ni se hayan vacunado, se administrarán 2 dosis con un intervalo mínimo de 4 semanas (preferiblemente 8 semanas). Si tienen una dosis previa, se administrará una dosis. En adultos, se realizará serología de varicela (IgG) si no presenta antecedentes de enfermedad ni de vacunación. Esta vacunación está contraindicada en embarazadas y en personas inmunodeprimidas.

VPH ¹⁴: Vacuna frente a virus del papilomavirus humano (VPH) en chicos y chicas de 12 años (nacidos en 2012) (Gardasil 9®): se administrará 1 dosis.

VPH ¹⁵: Vacuna de rescate frente a papilomavirus humano (VPH) (Gardasil 9®): se administrará 1 dosis a las chicas y chicos de 13 a 18 años que no hubieran recibido aún ninguna dosis de cualquier vacuna frente a VPH (Cervarix®, Gardasil® o Gardasil 9®).

Gripe ¹⁶: Vacuna antigripal durante el embarazo: en cada campaña de gripe se vacunará a todas las embarazadas en cualquier trimestre de gestación o durante los primeros 6 meses del puerperio.

Gripe ¹⁷: Vacuna antigripal anual de 6 a 59 meses: en cada campaña anual de gripe se vacunará a todos los niños y niñas que tengan esta edad durante la campaña con 1 dosis de cualquiera de las vacunas disponibles autorizadas para su edad.

Gripe anual ¹⁸: Vacuna antigripal anual en personas de 60 años o más: en cada campaña anual de gripe, se recomienda la vacunación de todas las personas de 60 años o más.

Herpes zóster ¹⁹: Vacunación sistemática frente a herpes zóster (Shingrix®): se administrará una pauta de 2 dosis, separadas por al menos 2 meses a las personas de 65 años (nacidos en 1959).

Bibliografía:

<https://www.andavac.es/wp-content/uploads/calendario/Calendario-Vacunaciones-Andalucia.pdf>

Consejería de Salud, Junta de Andalucía, 13-05-2024.

Servicio de Medicina Preventiva y Salud Pública del Hospital Universitario Virgende las Nieves. Vacunas.

Este servicio tiene implantados en la consulta de vacunación de pacientes de riesgo los siguientes protocolos específicos para pacientes con:

- Tratamiento inmunosupresor (1) (2)
- Esclerosis Múltiple (1) (2)
- Esplenectomía (funcional o quirúrgica)
- Patologías oncológicas y Hemopatías malignas (1) (2)
- Trasplante de progenitores hematopoyéticos
- Trasplante Órgano Sólido (1) (2)
- HIV (1)
- HSH (1)
- Prostitución (1)
- Prediálisis y Diálisis (1, solo Hepatitis B)
- Tratamiento con Eculizumab o Ravulizumab
- Indicación de Vacuna del Papiloma Humano

- Indicación de Rotavirus
- Respuesta humoral a la vacunación en pacientes con inmunodeficiencias

Procedimiento de derivación:

El paciente acudirá a la secretaría del Servicio de Medicina Preventiva (primera planta del Hospital General del Hospital Universitario Virgen de las Nieves) para solicitud de cita, aportando el informe de la consulta del especialista que le deriva.

Recomendaciones para la correcta vacunación:

-Si el paciente está tomando corticoides, deberá hacerlo a dosis inferiores a 20 mg de Prednisona (o equivalente) al día.

Leyendas:

(1) El Servicio que deriva solicitará la siguiente serología:

- Hepatitis B (Ag HBs, Ac HBc y Ac antiHBs)
- Hepatitis A (IgG VHA).
- Triple vírica (IgG Sarampión, IgG Rubeola, IgG Parotiditis)
- Varicela (IgG Varicela)

*En el peticionario de laboratorio se ha elaborado un perfil que contiene dicha serología. Se llama: **PREV- Vacunación Pacientes de Riesgo**

Los resultados de esta serología deberán de estar disponibles el día de la primera cita en la consulta de Medicina Preventiva, para valoración de la vacunación.

(2) Administración de vacunas atenuadas:

-Administración de la vacuna previa al inicio de tratamiento inmunosupresor. Este tratamiento inmunosupresor deberá iniciarse tras un intervalo mínimo de 8 semanas (tras la vacunación).

Es fundamental que se indique en el informe de derivación si es posible postponer como mínimo 8 semanas el inicio del tratamiento. Si NO es posible postponer o NO CONSTA esta información en el informe, NO se administrarán estas vacunas atenuadas.

-Administración de la vacuna tras finalización de tratamiento inmunosupresor. La administración de la vacuna deberá iniciarse tras un intervalo variable según el fármaco utilizado. Será de 3-6 meses tras el tratamiento con anti-TNF α (Adalimumab, Infliximab, etc) o anti-interleukina (Ustekinumab, guselkumab, etc) y de 12 meses tras Anticuerpos Monoclonales dirigidos a Receptores de Linfocitos B (Anti-CD20 como el Rituximab, Ocrelizumab, etc).